



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN BUDAYA KESELAMATAN
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

LEMBAR PENGESAHAN

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor

Tentang
Panduan Budaya Keselamatan

Disusun oleh :
Ketua Komite PMKP



(dr. Diah Puspita Rifasanti, Sp.M)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes AFP)

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M.Kes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Panduan Budaya Keselamatan Rumah Sakit Prima Husada dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Panduan Budaya Keselamatan ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2026. Kami mengucapkan terimah kasih Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para contributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Budaya Keselamatan ini pelayanan rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 09 Maret 2026

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

TIM PENYUSUN

PENGARAH

- 1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CHAE

PENYUSUN

- 1. dr. Resti Lestantini, M.Kes
- 2. dr. Diah Puspita Rifasanti, Sp.M
- 3. dr. Isrotul Anisa
- 4. Alifia Dian Sukmaningtyas, S.Kep., Ns
- 5. Sherly Rosita, S.Kep., Ns
- 6. Faisal Aminuddin Ilham, S.KM

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR ii

TIM PENYUSUN iii

DAFTAR ISI iv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Tujuan..... 1

BAB II 2

BUDAYA KESELAMATAN PASIEN 2

BAB III 4

LANGKAH SURVEY 4

BAB IV 7

PENUTUP 7



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 138/I-KEP/DIR/III/2026**

TENTANG

**PANDUAN BUDAYA KESELAMATAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pelayanan kesehatan perlu mengatur Rumah Sakit dengan Peraturan;
- b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 137/I-PND/DIR/III/2026 tentang Panduan Budaya Keselamatan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan di rumah sakit, sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit tentang Panduan Budaya Keselamatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Undang – Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Praktik Kedokteran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
11. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi RS
12. Kepdirjen Nomor Hk.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
13. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 773.145/I-KEP/DIR/VI/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada
14. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 262/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
Kesatu : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG
PEDOMAN PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN**

Pasal 1

1. Direktur rumah sakit telah melaksanakan pengukuran budaya keselamatan minimal 1 tahun sekali.

Pasal 2

1. Direktur Rumah Sakit mendukung terciptanya budaya keterbukaan yang dilandasi akuntabilitas.
2. Direktur Rumah Sakit mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan melaksanakan perbaikan perilaku yang tidak dapat diterima.
3. Direktur rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan menyediakan informasi (seperti bahan pustaka dan laporan) yang terkait dengan budaya keselamatan rumah sakit bagi semua individu yang bekerja dalam rumah sakit.
4. Direktur Rumah Sakit menjelaskan bagaimana masalah terkait budaya keselamatan dalam rumah sakit dapat diidentifikasi dan dikendalikan.
5. Direktur Rumah Sakit menyediakan sumber daya untuk mendukung dan mendorong budaya keselamatan di dalam rumah sakit.

Pasal 3

1. Direktur Rumah Sakit menetapkan regulasi pengaturan sistem menjaga kerahasiaan, sederhana, dan mudah diakses oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk melaporkan masalah yang terkait dengan budaya keselamatan dalam rumah sakit secara tepat waktu.
2. Sistem yang rahasia, sederhana, dan mudah diakses oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk melaporkan masalah yang terkait dengan budaya keselamatan dalam rumah sakit telah disediakan.
3. Semua laporan terkait dengan budaya keselamatan rumah sakit telah diinvestigasi secara tepat waktu.
4. Ada bukti bahwa identifikasi masalah pada sistem yang menyebabkan tenaga kesehatan melakukan perilaku yang berbahaya telah dilaksanakan.
5. Direktur Rumah Sakit telah menggunakan pengukuran/indikator mutu untuk mengevaluasi dan memantau budaya keselamatan dalam rumahsakit serta melaksanakan perbaikan yang telah teridentifikasi dari pengukuran dan evaluasi tersebut.
6. Direktur Rumah Sakit menerapkan sebuah proses untuk mencegah kerugian/dampak terhadap individu yang melaporkan masalah terkait dengan budaya keselamatan tersebut.



Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 09 Maret 2026
PLT Direktur RS Prima Husada Malang

dr. Resti Lestantini, M.Kes

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR:
TENTANG PANDUAN BUDAYA
KESELAMATAN

PANDUAN BUDAYA KESELAMATAN

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Organisasi yang bekerja untuk mengembangkan atau meningkatkan budaya keselamatan membutuhkan tindakan yang dapat diandalkan untuk memantau keberhasilan inisiatif mereka. Dengan menggunakan alat survei ini, sebuah organisasi dapat memperoleh informasi tentang persepsi staf klinis garis depan tentang keselamatan di area klinis mereka dan komitmen manajemen terhadap keselamatan. Survei ini juga memberikan informasi tentang bagaimana persepsi bervariasi di berbagai departemen dan disiplin ilmu. Ketika tim menguji dan mengimplementasikan perubahan untuk meningkatkan budaya, seperti Briefing Keselamatan dan Walkway Kepemimpinan Keselamatan Pasien, dapat mengulangi survei ini secara berkala untuk menilai dampak dari perubahan tersebut

Pengukuran budaya keselamatan juga perlu dilakukan oleh rumah sakit. Budaya keselamatan juga dikenal sebagai budaya yang aman, yakni sebuah budaya organisasi yang mendorong setiap individu anggota staf (klinis atau administratif) melaporkan hal-hal yang mengkhawatirkan tentang keselamatan atau mutu pelayanan tanpa imbal jasa dari rumah sakit.

Direktur rumah sakit melakukan evaluasi rutin sesuai jadwal yang tetap dengan menggunakan beberapa metode, survei resmi, wawancara staf, analisis data, dan diskusi kelompok.

1.2 Tujuan

Adapun maksud penyusunan pedoman agar menciptakan dan mendukung budaya keselamatan di seluruh area rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BUDAYA KESELAMATAN PASIEN

Budaya keselamatan dapat diartikan sebagai berikut: “Budaya keselamatan di rumah sakit adalah sebuah lingkungan yang kolaboratif karena staf klinis memper- lakukan satu sama lain secara hormat dengan melibatkan serta memberdayakan pasien dan keluarga. Pimpinan mendorong staf klinis pemberi asuhan bekerja sama dalam tim yang efektif dan mendukung proses kolaborasi interprofesional dalam asuhan berfokus pada pasien.

Budaya keselamatan juga merupakan hasil dari nilai-nilai, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku individu maupun kelompok yang menentukan komitmen terhadap, serta kemampuan manajemen pelayanan kesehatan maupun keselamatan. Budaya keselamatan dicirikan dengan komunikasi yang berdasar atas rasa saling percaya dengan persepsi yang sama tentang pentingnya keselamatan dan dengan keyakinan akan manfaat langkah-langkah pencegahan.

Tim belajar dari kejadian tidak diharapkan dan kejadian nyaris cedera. Staf klinis pemberi asuhan menyadari keterbatasan kinerja manusia dalam sistem yang kompleks dan ada proses yang terlihat dari belajar serta menjalankan perbaikan melalui briefing.

Keselamatan dan mutu berkembang dalam suatu lingkungan yang mendukung kerjasama dan rasa hormat terhadap sesama tanpa melihat jabatan mereka dalam rumah sakit. Direktur rumahsakit menunjukkan komitmennya tentang budaya keselamatan dan mendorong budaya keselamatan untuk seluruh staf rumah sakit. Perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan adalah:

1. Perilaku yang tidak layak (*inappropriate*) seperti kata-kata atau bahasa tubuh yang merendahkan atau menyinggung perasaan sesama staf, misalnya mengumpat dan memaki.
2. Perilaku yang mengganggu (*disruptive*) antara lain perilaku tidak layak yang dilakukan secara berulang, bentuk tindakan verbal atau nonverbal yang membahayakan atau mengintimidasi staf lain, dan “celetukan maut” adalah komentar sembrono di depan pasien yang berdampak menurunkan kredibilitas staf klinis lain. Contoh mengomentari negatif hasil tindakan atau pengobatan staf lain di depan pasien, misalnya “obatnya ini salah, tamatan mana dia...?”, melarang perawat untuk mem- buat laporan tentang kejadian tidak diharapkan, memarahi staf klinis lainnya di de- pan pasien, kemarahan yang ditunjukkan dengan melempar alat bedah di kamar operasi, serta membuang rekam medis di ruang rawat.
3. Perilaku yang melecehkan (*harassment*) terkait dengan ras, agama, dan suku termasuk gender.
4. Pelecehan Seksual.

Hal-hal penting menuju budaya keselamatan:

1. Staf rumah sakit mengetahui bahwa kegiatan operasional rumah sakit berisiko tinggi dan bertekad untuk melaksanakan tugas dengan konsisten serta aman.
2. Regulasi serta lingkungan kerja mendorong staf tidak takut mendapat hukuman bila membuat laporan tentang kejadian tidak diharapkan dan kejadian nyaris cedera.
3. Direktur rumah sakit mendorong tim keselamatan pasien melaporkan insiden keselamatan pasien ke tingkat nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Mendorong kolaborasi antarstaf klinis dengan pimpinan untuk mencari penyelesaian masalah keselamatan pasien.

Komitmen organisasi menyediakan sumber daya, seperti staf, pelatihan, metodepelaporan yang aman, dan sebagainya untuk menangani masalah keselamatan.

Masih banyak rumah sakit yang masih memiliki budaya untuk menyalahkan suatu pihak yang akhirnya merugikan kemajuan budaya keselamatan. *Just culture* adalah model terkini mengenaipembentukan suatu budaya yang terbuka, adil dan pantas, menciptakan budaya belajar, merancang sistem-sistem yang aman, serta mengelola perilaku yang terpilih (*human*

error, at risk behavior, dan reckless behavior, dan *reckless behavior*). Model ini melihat peristiwa- peristiwa bukan sebagai hal-hal yang perlu diperbaiki, tetapi sebagai peluang-peluang untuk memperbaiki pemahaman baik terhadap risiko dari sistem maupun risiko perilaku.

Ada saat-saat individu seharusnya tidak disalahkan atas suatu kekeliruan; sebagai contoh, ketika ada komunikasi yang buruk antara pasien dan staf, ketika perlu pengambilan keputusan secara cepat, dan ketika ada kekurangan faktor manusia dalam pola proses pelayanan. Namun,terdapat juga kesalahan tertentu yang merupakan hasil dari perilaku yang sembrono dan hal ini membutuhkan pertanggungjawaban. Contoh dari perilaku sembrono mencakup kegagalan dalam mengikuti pedoman kebersihan tangan, tidak melakukan *time out* sebelum mulainya operasi, atau tidak memberi tanda pada lokasi pembedahan.

Budaya keselamatan mencakup mengenali dan menunjukan masalah yang terkait dengan sistem yang mengarah pada perilaku yang tidak aman. Pada saat yang sama, rumah sakit harus memelihara pertanggungjawaban dengan tidak mentoleransi perilaku sembrono. Pertanggungjawaban membedakan kesalahan unsur manusia (seperti kekeliruan), perilaku yang berisiko (contohnya mengambil jalan pintas), dan perilaku sembrono (seperti mengabaikan langkah-langkah keselamatan yang sudah ditetapkan).

Direktur Rumah Sakit melakukan evaluasi rutin dengan jadwal yang tetap dengan menggunakan beberapa metode, survei resmi, wawancara staf, analisis data, dan diskusi kelompok.

Direktur Rumah Sakit mendorong agar dapat terbentuk kerja sama untuk membuat struktur, proses, dan program yang memberikan jalan bagi perkembangan budaya positif ini.

Direktur Rumah Sakit harus menanggapi perilaku yang tidak terpuji dari semua individu dari semua jenjang rumah sakit, termasuk manajemen, staf administrasi, staf klinis, dokter tamu atau dokter *part time*, serta anggota representasi pemilik.

BAB III

LANGKAH SURVEY

Langkah 1: Pilih Unit untuk Survei

Ketika pertama kali menggunakan Survei Budaya Keselamatan, Anda mungkin ingin mensurvei staf hanya pada satu atau dua unit percontohan, daripada seluruh organisasi. Ini akan membantu Anda mempelajari cara menggunakan survei, menginterpretasikan hasil, dan menguji perubahan pada skala kecil terlebih dahulu untuk melihat apakah mereka menghasilkan peningkatan. Pilih unit percontohan yang sudah menguji perubahan untuk meningkatkan keselamatan pasien, dan ukur budaya keamanan di sana dari waktu ke waktu untuk menilai dampak dari perubahan.

Langkah 2: Identifikasi Staf untuk Berpartisipasi dalam Survei

Budaya keamanan di unit perawatan pasien dipengaruhi oleh dan dialami oleh semua orang yang bekerja di unit itu. Ini termasuk karyawan dari berbagai disiplin ilmu yang mungkin sering ditugaskan ke unit itu, seperti apoteker, terapis pernapasan, dan ahli diet. Ini juga termasuk dokter yang sering merawat pasien di unit itu, apakah mereka adalah karyawan, anggota staf medis sukarela, atau peserta dalam program pengajaran. Semua individu yang secara teratur bekerja atau ditugaskan ke unit perawatan pasien harus dimasukkan dalam survei.

Berikut ini beberapa panduan umum untuk menentukan anggota staf mana yang harus disertakan:

1. Pilih anggota staf yang secara teratur bekerja setidaknya 20 jam per minggu di unit itu. Jangan memasukkan anggota staf yang bekerja di sana hanya sesekali.
2. Pilih anggota staf dari departemen lain yang ditugaskan terutama ke unit itu atau yang ditugaskan di sana setidaknya tiga hari per minggu.
3. Pilih dokter yang mengobati, rata-rata, setidaknya tiga pasien per minggu di unit. Jika ada banyak dokter dalam kategori ini, seperti yang terjadi pada unit besar, pertimbangkan termasuk 10 atau 20 dokter yang merawat sebagian besar pasien di unit.
4. Pastikan semua peserta survei (staf dan dokter) telah bekerja di unit setidaknya selama enam minggu.

Langkah 3: Nomor dan Lacak Survei

Cetak satu formulir survei untuk setiap orang yang akan disurvei. Mempertahankan anonimitas sangat penting dengan survei, tetapi sangat membantu untuk menghitung dan mengelompokkan survei untuk membandingkan respons antar disiplin. Berikut ini beberapa saran untuk penomoran survei: Kembangkan sistem penomoran sehingga Anda dapat melacak hasilnya. Anda mungkin ingin nomor pelacakan Anda menyertakan bulan dan tahun survei, yang akan membantu dalam menjaga data terorganisir jika Anda melakukan survei beberapa kali. Jangan menggunakan kode yang secara jelas mengidentifikasi unit atau disiplin (mis., "RN100" atau "MD310"), karena orang mungkin takut diidentifikasi.

Contoh survei penomoran:

Rumah Sakit ABC melakukan survei budaya keselamatan di satu unit perawatan pasien. Dengan menggunakan kriteria yang dijelaskan pada Langkah 2 di atas, rumah sakit menetapkan bahwa unit memerlukan 120 survei. Rumah sakit sedang melakukan survei pada bulan Januari 2003, sehingga survei diberi nomor secara berurutan sebagai 0103-001 hingga 0103-120. Rentang survei adalah sebagai berikut:

1. 0103-001 melalui 0103-050 : Perawat

2. 0103-051 hingga 0103-065 : Dokter
3. 0103-066 hingga 0103-070 : Apoteker
4. 0103-071 hingga 0103-075 : Fisioterapi
5. 0103-076 hingga 0103-080 : Ahli gizi
6. 0103-081 hingga 0103-090 : Case manager/ MPP
7. 0103-091 hingga 0103-115 : Bidan

Jika Anda menggunakan sistem penomoran dengan rentang seperti yang disebutkan di atas, jangan tulis nomor survei mana yang sesuai dengan masing-masing anggota staf. Itu akan menghilangkan anonimitas dan risiko mengorbankan hasil. Pastikan untuk memberi setiap peserta survei dari kisaran yang sesuai dengan pekerjaannya.

Langkah 4: Lacak Respons Tarif

Tingkat respons yang baik sangat penting untuk hasil yang berarti. Disarankan agar Anda memiliki tingkat respons minimal 65 persen sebelum menganalisis dan menggunakan hasilnya. Jika Anda menggunakan sistem penomoran dengan rentang, Anda dapat melihat disiplin yang telah mengembalikan survei. Menjelaskan tujuan survei dan metode analisis sebelum Anda mendistribusikan survei dapat membantu Anda mencapai tingkat respons yang tinggi.

Gunakan rentang dari sistem penomoran untuk melacak berapa banyak orang dalam setiap kategori pekerjaan yang mengembalikan survei. Ini akan membantu memastikan bahwa jumlah orang yang sama disurvei kembali dalam setiap kategori di masa depan (dan akan membantu Anda mengimbangi gesekan responden saat orang meninggalkan organisasi). Misalnya, jika 12 dokter dan tiga apoteker menanggapi survei pertama, Anda akan ingin mendapatkan kira-kira jumlah tanggapan yang sama dari masing-masing dalam survei mendatang.

Langkah 5: Hitung Hasil

Anda dapat menghitung Mean Keseluruhan, Budaya Keselamatan, Skor Budaya Keselamatan, dan Persentase Responden Melaporkan Budaya Keselamatan yang Positif dengan mengikuti langkah-langkah ini:

1. Tetapkan nilai numerik ke respons untuk setiap pertanyaan (kecuali untuk # 18) sebagai berikut:
TINGKATKAN SANGAT KEMBALI = 1
TAK SEGERA SETELAH = 2
NETRAL = 3
SETUJU DENGAN BENAR = 4
SETUJU DENGAN SANGAT = 5
TIDAK BERLAKU Tanpa Skor
Tidak Ada Tanggapan Tanpa Skor
2. Membalikkan skor untuk Pertanyaan # 18 saja, karena kata-kata pertanyaan, sebagai berikut:
TINGKATKAN SANGAT KEMBALI = 5
TAK SEGERA SETELAH = 4
NETRAL = 3
SETUJU DENGAN BENAR = 2 SETUJU
DENGAN SANGAT = 1
TIDAK BERLAKU Tanpa Skor
Tidak Ada Tanggapan Tanpa Skor
3. Lakukan:
 - a. Tambahkan skor dari setiap pertanyaan yang dijawab.
 - b. Bagilah jumlah dengan jumlah pertanyaan yang dijawab. Jika ada pertanyaan yang dijawab sebagai "Tidak Berlaku" atau dibiarkan kosong, jangan menghitungnya dalam

-
- penyebut.
- c. Hasilnya adalah Mean Keseluruhan untuk responden individu dan akan antara 1 dan 5.
 - d. Tambahkan Keseluruhan Sarana dari semua survei yang dikembalikan dan bagi dengan jumlah responden. Ini memberikan Mean Keseluruhan untuk grup, yang juga akan berada di antara 1 dan 5.
4. Untuk menghitung *Safety Climate Mean*:
- a. Tambahkan nomor hanya dari pertanyaan-pertanyaan berikut, jika dijawab: Pertanyaan 1, 2, 8, 9, 10, 11, dan 18.
 - b. Bagilah jumlah dengan jumlah pertanyaan-pertanyaan ini dijawab. Jika ada yang dijawab sebagai "Tidak Berlaku" atau dibiarkan kosong, jangan menghitungnya dalam penyebut.
 - c. Hasilnya adalah Budaya Keselamatan Berarti untuk responden individu dan akan berada antara 1 dan 5.
 - d. Tambahkan Sarana Budaya Keselamatan dari semua survei yang dikembalikan dan dibagi dengan jumlah responden (kecualikan setiap responden yang tidak menjawab semua tujuh pertanyaan ini). Ini memberikan *Safety Climate Mean* untuk grup, yang juga akan berada antara 1 dan 5.
 - e. Untuk menghitung Skor Budaya Keselamatan:
 - 1) Kurangi 1 dari Budaya Keselamatan Berarti pada survei individu.
 - 2) Kalikan hasilnya dengan 25 untuk mengkonversi ke skala 100 poin.
 - 3) Hasilnya adalah Skor Budaya Keselamatan untuk responden tersebut, yang akan berada antara 1 dan 100.
 - 4) Hitung Skor Budaya Keselamatan untuk sisa survei.
5. Untuk menghitung Persen Responden Melaporkan Budaya Keselamatan yang Positif:
- a. Hitung jumlah responden dengan Skor Budaya Keselamatan 75 atau lebih besar.
 - b. Bagilah dengan jumlah total responden.
 - c. Hasilnya adalah Persen Responden Melaporkan Budaya Keselamatan Positif.

Langkah 6: Pantau Hasil Seiring Waktu

Dua hasil yang harus dilacak dari waktu ke waktu adalah *Safety Climate Mean* dari semua responden, langkah (d) di atas, dan Persen Responden Melaporkan Budaya Keselamatan Positif, langkah (f) di atas. Nilai rata-rata untuk pertanyaan individu dapat membantu Anda menganalisis area organisasi Anda yang perlu ditingkatkan. Mungkin juga membantu membandingkan hasil lintas disiplin atau dari unit yang berbeda.

Langkah 7: Lakukan Survei Ulang

Ingat bahwa mengubah budaya organisasi membutuhkan waktu yang lama. Jangan terlalu sering melakukan survei ulang. Hasil tidak cepat berubah. Selain itu, jika anggota staf terlalu sering disurvei, mereka akan menjadi tidak peka terhadap proses dan hasilnya akan terpengaruh. Rencana yang baik mungkin untuk mendapatkan ukuran budaya keselamatan dasar, dan kemudian melakukan survei lanjutan pada 6 bulan dan 12 bulan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman yang disusun ini merupakan langkah awal sebagai pedoman/panduan bagi rumah sakit untuk melakukan pengukuran, evaluasi dan tindak lanjut terhadap Indikator RS. Pedoman ini diharapkan dapat diterapkan oleh RS dan menjadi pedoman bersama dalam mengukur Indikator rumah sakit.

Hasil pengukuran indikator rumah sakit tersebut kedepannya diharapkan dapat diakses dan dipublikasikan untuk perbaikan internal rumah sakit dan eksternal untuk bukti akuntabilitas pada masyarakat. Buku pedoman ini masih dalam tahap perkembangan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya masukan demi tercapainya perbaikan bagi buku pedoman ini.

Hormat Kami,
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes